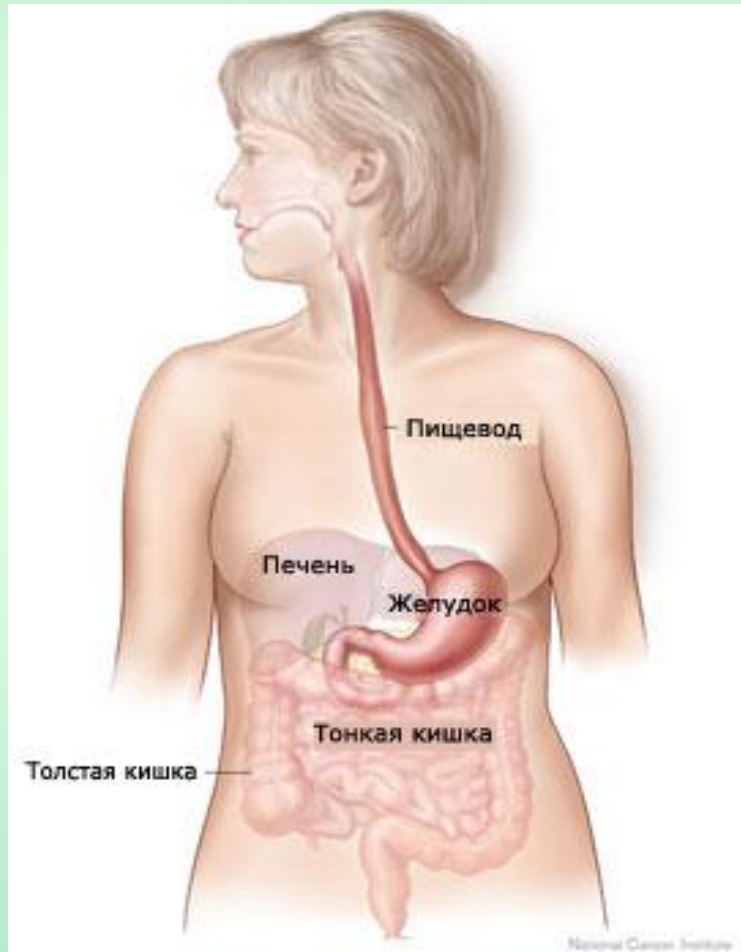


Антонов Андрей Борисович

Хронический гастрит

**Кафедра факультетской терапии
СГМУ
Архангельск**

Хронический гастрит

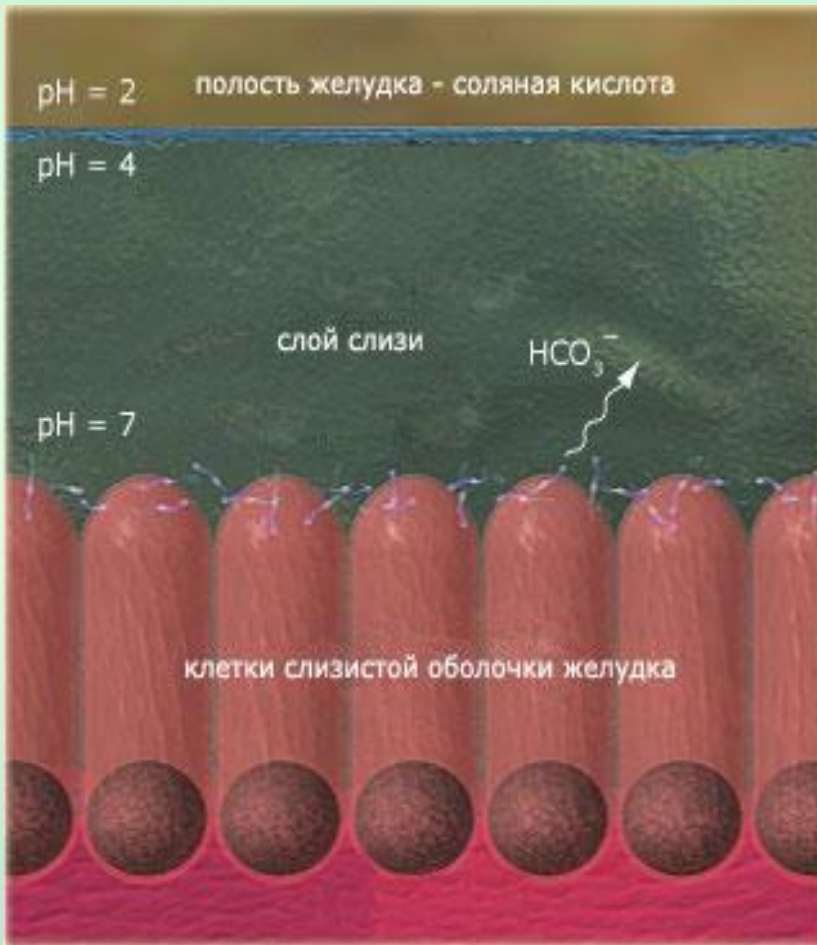


- Широко распространенное заболевание.
- Обращается только 10 - 15% лиц.
- На долю гастрита приходится 85% от всех заболеваний желудка.

Определение

- **Хронический гастрит** – группа хронических заболеваний, которые **морфологически** характеризуются воспалительными и дистрофическими процессами в слизистой оболочке желудка.
- МКБ-10: К 29 Гастрит и дуоденит

Физиология



- Клетки слизистой оболочки постоянно выделяют слизь и щелочь (бикарбонат).
- Благодаря защитному слою слизи имеет место следующая ситуация: в полости желудка среда резко кислая (рН составляет 2,0), а под слизью, которой укутаны клетки, среда нейтральная (рН составляет 7,0).

Медиаторы секреции соляной кислоты

Ацетилхолин	Источником являются постганглионарные волокна, блуждающий нерв около париетальных клеток
Гастрин	Продуцируется G-клетками антрального отдела, из кровотока по системе микроциркуляции поступает в париетальные клетки
Гистамин	Продуцируется тучными клетками в интерстициальном пространстве около париетальных клеток

Патофизиология

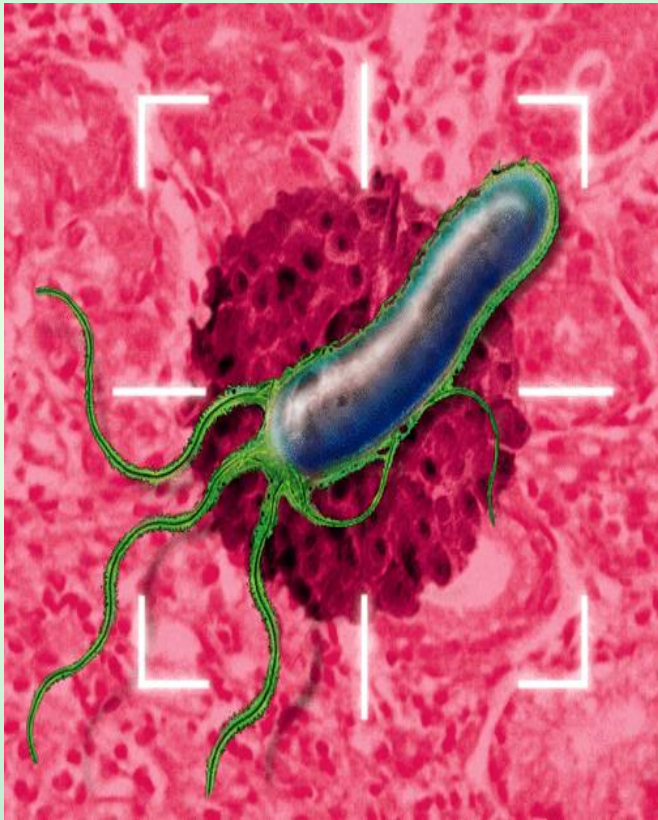


- При нарушении защитного барьера слизистая оболочка под действием соляной кислоты и пепсина повреждается. Клетки слизистой оболочки гибнут, в стенке желудка развивается хроническое воспаление

Этиология хронических гастритов

- **Хеликобактерная инфекция (Hr)** – причина хронического гастрита в 95% случаев.
- Hr относится к числу патогенных бактерий, хотя в зависимости от обстоятельств может вести себя как комменсал и даже симбионт.
- Продуцирует ферменты: уреазу, ЩФ, протеазу, муциназу, гемолизин, белок, ингибирующий секрецию HCL и др.

Характеристика *Helicobacter pylori*

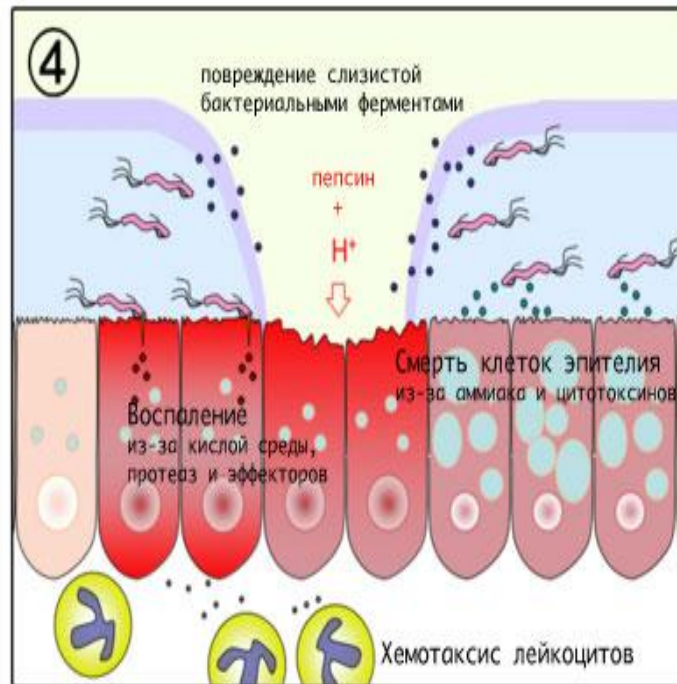
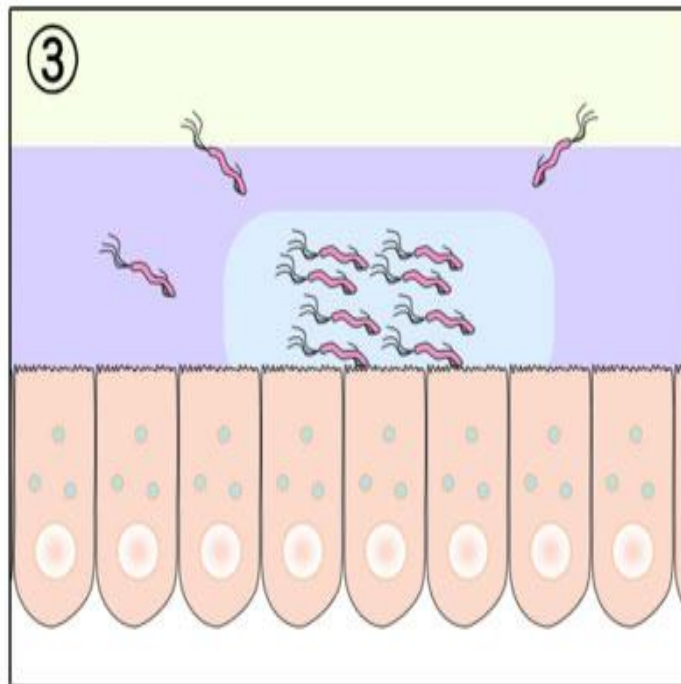
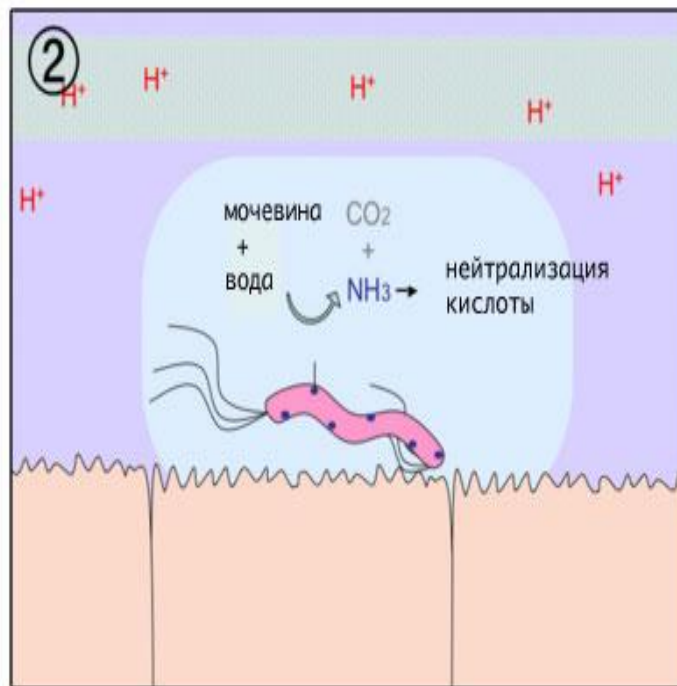
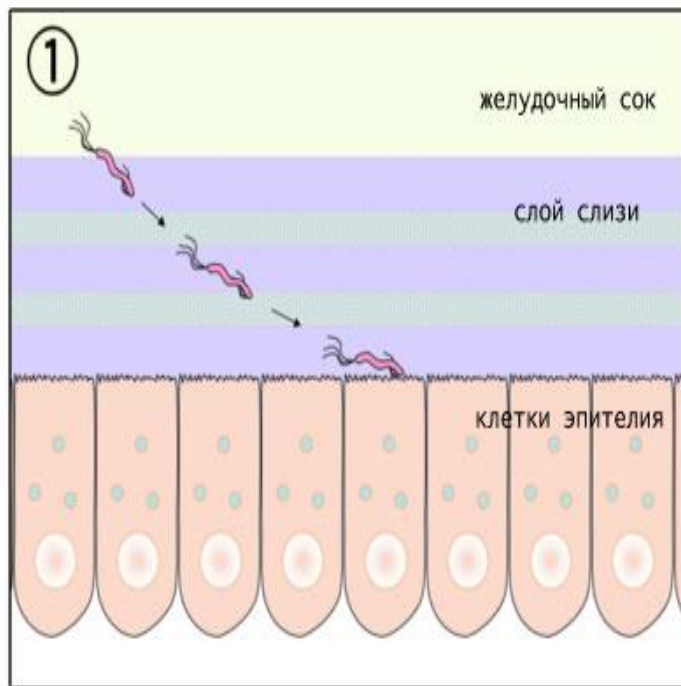


Нр – грамотрицательная спиральная, изогнутая или прямая палочка, диаметром 0,5-1 мкм, длиной 2,5-5 мкм, с закругленными концами. Подвижна за счет жгутиков.

Род *Helicobacter* насчитывает примерно 30 видов, из их числа 24 вида признаны официально.

Хеликобактерная инфекция

- Благоприятная среда: температура 37-42С, рН 4-6.
- Широко распространена среди населения, в 60-летнем возрасте может быть инфицировано 50% населения.
- Источник инфекции – человек – больной или бактерионоситель.
- Путь передачи – орально-оральный, фекально-оральный.
- Вначале локализуется в антральной области, затем переходит на тело или весь желудок.

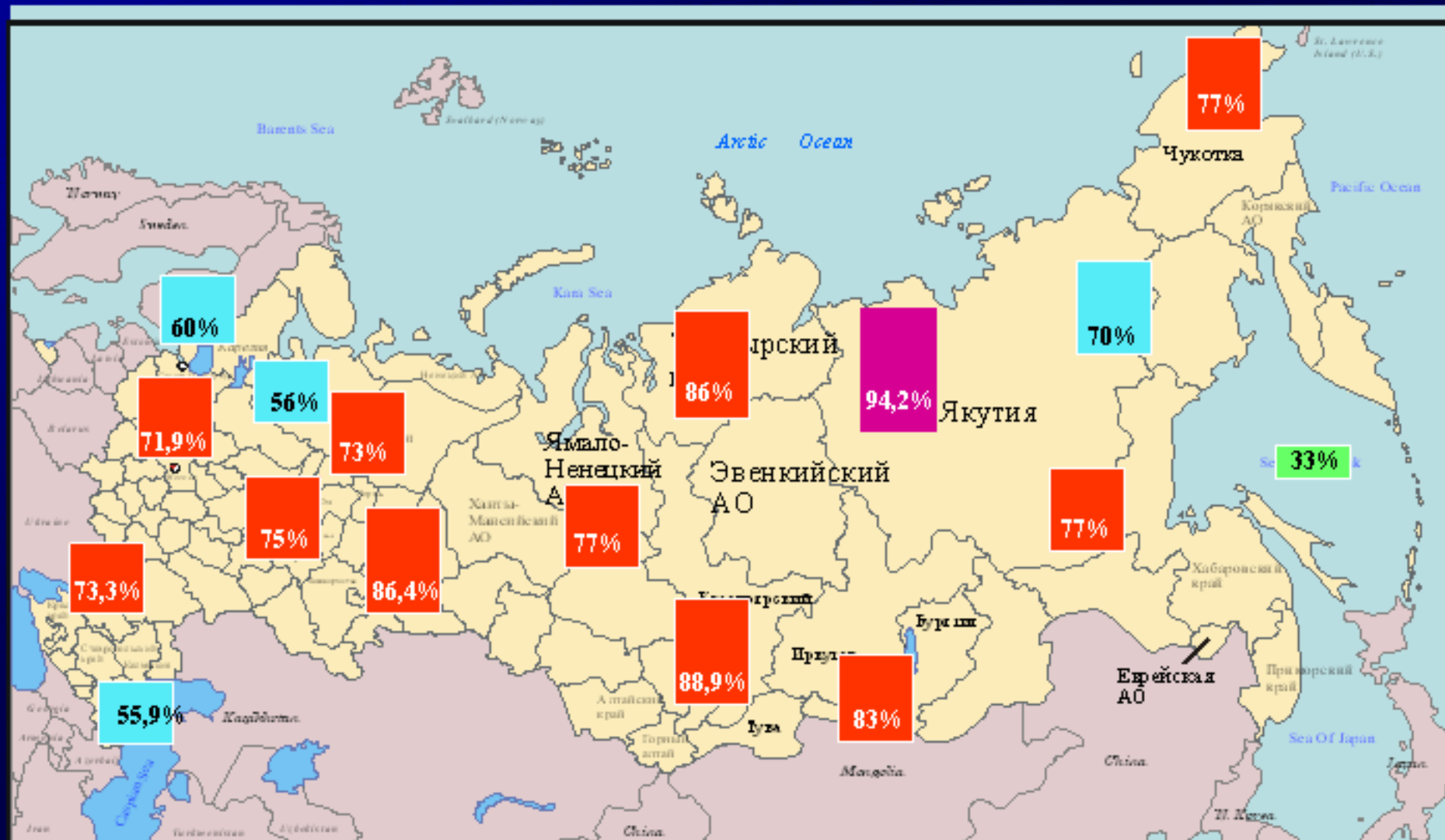


- 1) проникает через слой слизи в желудке хозяина и прикрепляется к эпителиальным клеткам;
- 2) бактерии катализируют превращение мочевины в аммиак, нейтрализуя кислотную среду кишечника;
- 3) размножаются, мигрируют и образуют инфекционный центр;
- 4) в результате разрушения слизистой, воспаления и смерти клеток эпителия образуются язвы желудка.



Нобелевская премия в области физиологии и медицины в 2005 году присуждена Р.Уоррену и Б.Маршаллу «за их открытие бактерии *Helicobacter pylori* и ее роли при гастрите и язвенной болезни».

Частота инфекции *H.pylori* в России (взрослые)



Слайд любезно предоставлен проф. П. Л. Щербаковым

Этиология хронических гастритов

Аутоиммунный фактор

- Причина в 15-18% случаев;
- Обусловлен образованием аутоантител к париетальным клеткам слизистой оболочки, вырабатывающих соляную кислоту и внутренний фактор Касла – гастромукопротеин;
- Локализуется в фундальном отделе и теле желудка.

Другие этиологические факторы

- **Дуодено-гастральный рефлюкс – заброс дуоденального и панкреатического сока, смешенного с желчью, приводя к рефлюкс-гастриту.**
- **Воздействие лекарственных средств – салицилаты, НПВС, противотуберкулезные препараты.**
- **Пищевая аллергия – в слизистой оболочке обнаруживается эозинофильная инфильтрация, тучные клетки у больных с пищевой аллергией.**
- **Профессиональные вредности – угольная, металлическая, хлопковая пыль, пары кислот, щелочей.**

Алиментарный фактор

- **Нарушение режима питания (нерегулярное, торопливое).**
- **Употребление недоброкачественной пищи, острой, копченой, жареной, очень горячей или холодной.**

Вредные привычки

- **Злоупотребление алкоголем (прямое и опосредованное действие).**
- **Курение: нарушение регенерации желудочного эпителия, секреторной функции желудка, слизистого барьера.**

Воздействие эндогенных факторов

- **Хронические инфекции (брюшной полости, органов дыхания).**
- **Заболевания эндокринной системы (хр. надпочечниковая недостаточность, сахарный диабет, гипотиреоз).**
- **Нарушение обмена веществ (ожирение, подагра).**
- **Дефицит железа в организме.**
- **Аутоинтоксикация при ХПН.**
- **Тканевая гипоксия.**

Международная классификация

(Хьюстон, 1996г.)

Тип гастрита	Синонимы	Этиология
Неатрофический	Поверхностный, диффузный антральный, гиперсекреторный, тип В	H.Pylori
Аутоиммунный атрофический	Тип А, диффузный тела	Аутоиммунный
Химический	Реактивный рефлюкс-гастрит	Химические раздражители, желчь, НПВС
Радиационный		Лучевые поражения
Лимфоцитарный	Ассоциированный с целиакией	Идиопатический, иммунные механизмы, глютен
Неинфекционный гранулематоз		Гранулематоз Вегенера, инородные тела, идиопатический
Эозинофильный	Аллергический	Пищевая аллергия
Др. инфекционные		Бактерии, вирусы

Классификация по эндоскопической картине

- эритематозный**
- экссудативный**
- атрофический**
- геморрагический**
- рефлюкс-гастрит**
- гиперпластический**
- эрозивный**

Классификация по морфологической характеристике

- поверхностный
- интерстициальный
- атрофический
- с кишечной метаплазией

По наличию НР:

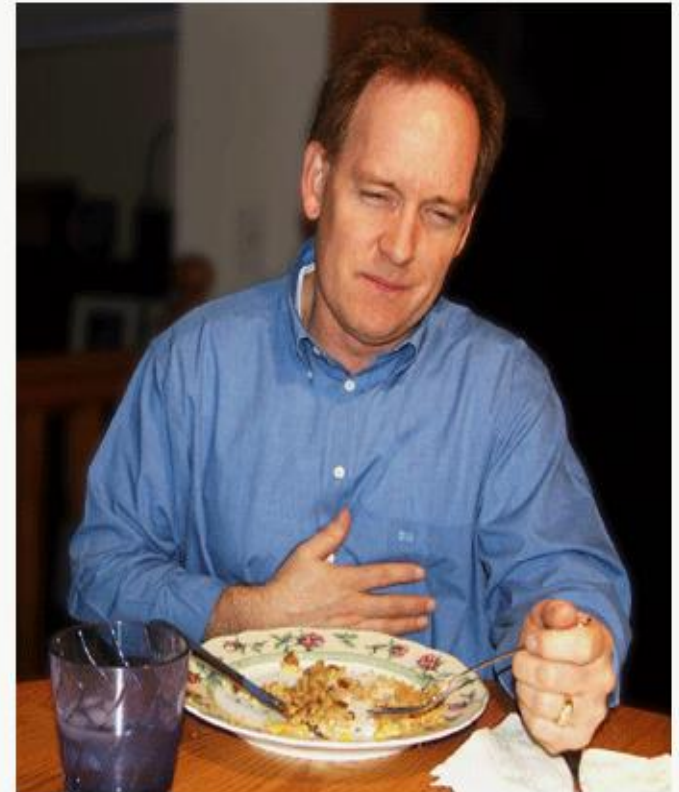
- Отсутствует
- +НР

Фаза:

обострение, ремиссия

Клинические синдромы

- **Болевой абдоминальный** – локализация в эпигастрии, боли сразу после еды или через 30-40 мин, провоцируются грубой, острой, жареной, копченой пищей, усиливаются при физической нагрузке, наиболее выражены при антральном НР гастрите, тупого характера.
- острые и приступообразные боли не характерны.



Клинические синдромы

- **Диспепсический** – выраженность зависит от состояния кислотообразующей функции желудка.
- **Желудочно-кишечный** – при присоединении энтерита к атрофическому анацидному гастриту с похуданием, диареей, метеоризмом, болями в животе в периоде интенсивного пищеварения.
- **Синдром полигиповитаминоза** – недостаток витаминов группы В и аскорбиновой кислоты, что выражается изменением десен (разрыхленность, кровоточивость), сухость кожи, изменения языка, признаки хейлита.

Клинические синдромы

- **Анемический** – тяжелый аутоиммунный с развитием В₁₂-дефицитной анемии с появлением утомляемости, сонливости, парестезии в конечностях, расстройство зрения, бледность кожи, субиктеричность, лакированный язык, расстройство чувствительности, в крови - мегалобластная анемия.
- **Геморрагический** – при эрозивном гастрите.
- **Астеноневротический** – слабость, раздражительность, зябкость, гипергидроз кистей и стоп.
- **Пищевая аллергия.**

Хронический неатрофический гастрит

(1)

- Болевой синдром: боли локализуются в эпигастрии, чаще тупые, возникают сразу после еды или в первые 30 мин – 40 мин, связаны с погрешностями в питании, носят периодический характер, непродолжительны.
- Диспептический синдром: отрыжка кислым, изжога, жжение в н/3 грудины, рвота кислым содержимым.
- Запоры, аппетит сохранен.
- Может быть геморрагический синдром (при наличии эрозий слизистой оболочки).

Хронический неатрофический гастрит

(2)

- **ФГДС: отек и изменение складок, гиперплазия, гиперемия, повышенная ранимость слизистой и эрозии.**
- **Рентгенологическое исследование: много жидкости натошак, спазм привратника, м.б. полипы**
- **Желудочный сок: повышение кислотной продукции, гиперацидность: БАО – базальная кислотная продукция - № или более 4 ммоль/час; САО – N или более 12 ммоль/час**

Хронический атрофический гастрит (1)

- Болевой синдром: слабо выражен или его нет, может быть по типу дискомфорта, чувства тяжести в эпигастрии, сразу после еды, усиливается при стоянии и ходьбе.
- Диспептический синдром: снижение аппетита, чувство быстрого насыщения, отрыжка воздухом или тухлым, пищей, горечь во рту.
- Кишечная диспепсия – поносы, метеоризм, урчание.
- Чувствительность к недоброкачественной пище (симптом чувствительного желудка).
- Может быть анемический синдром при аутоиммунном гастрите – В12-дефицитная анемия.
- Астеноневротический синдром (слабость, раздражительность, зябкость, гипергидроз кистей и стоп, иногда с сердечно-сосудистыми нарушениями).

Хронический атрофический гастрит (2)

- **ФГДС:** отек, гиперемия, блеск слизистой, видны сосуды при атрофическом гастрите, кровоизлияния в слизистую.
- **Рентгенологическое исследование:** зияние привратника, истончение складок, быстрая эвакуация пищи
- **Желудочный сок:** снижение общей кислотной продукции, гипоацидность: БАО – базальная кислотная продукция – менее 1 ммоль/час; САО – менее 6,5 ммоль/час; анацидность, т.е. свободная HCl до 0.

КЛАССИФИКАЦИЯ (ФОРМЫ ХГ)

Хронический аутоиммунный гастрит

(5% всех случаев ХГ) связан с образованием АТ к париетальным клеткам и внутреннему фактору Касла.

Характерный признак – первичное развитие атрофических изменений (воспаление в сочетании с истончением слизистой оболочки, утратой желез, метаплазией эпителия) слизистой оболочки фундального отдела желудка (локализация париетальных клеток) с дальнейшим переходом на антральный отдел.

Клинические особенности

- Хр. аутоиммунный гастрит наблюдают преимущественно в среднем и пожилом возрасте.
- Наследственная предрасположенность.
- Лимфоклеточная инфильтрация
- Рано развивается сниженная секреция (через 4 – 5 лет).
- Развитие В12-дефицитной анемии.
- Высокий уровень гастринемии.
- Часто сочетается с тиреоидитом, тиреотоксикозом, первичным гиперпаратиреозом.



Диагностика

Лабораторные исследования

- ОАК, ОАМ
- Кал на скрытую кровь
- Гистологическое и цитологическое исследование биоптата
- Два теста на НР
- Общий белок и белковые фракции, билирубин, АСТ, АЛТ

Диагностика

Инструментальные исследования

- **ФЭГДС с прицельной биопсией и щеточным цитологическим исследованием**
- **Ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, желчных путей и поджелудочной железы**

При подозрении на атрофический аутоиммунный гастрит

- развёрнутый анализ крови с тромбоцитами и ретикулоцитами
- содержание в крови витамина B_{12} (происходит снижение уровня менее 150 пг/мл)
- иммунологическое исследование — определение антител к структурам обкладочной клетки, ферменту H^+K^+ - АТФазе, внутреннему фактору Касла
- определение содержания гастрина в сыворотке крови натошак
- стеральная пункция (при подозрении на лейкоз)

Методы диагностики НР

- цитологический тест с использованием мазков-отпечатков
- гистологическое исследование биоптата
- уреазные экспресс-методы
- серологические
- уреазный дыхательный тест
- микробиологический метод

Цитологический тест

с использованием мазков-отпечатков

- **Высушенные мазки окрашиваются по Паненгейму или после фиксации метанол – азуроэозиновой смесью или готовым красителем Романовского – Гимзе.**
- **При наличии НР выделяют три степени обсемененности:**
 - **слабая (+) – до 20 микробных тел в поле зрения,**
 - **средняя (++) – от 20 до 40 микробных тел в поле зрения,**
 - **высокая (+++) – свыше 40 микробных тел в поле зрения.**

НР располагаются в слизи и имеют спиралевидную, изогнутую или S– образную форму или вид «крыльев летящей бабочки». В отпечатках можно выявить и клеточную инфильтрацию, определяющую степень активности и характер воспалительного процесса.

Гистологическое исследование биоптата

- **Гистологическое исследование биоптата с оценкой степени обсеменения микробными телами**
 - 1-ая – менее 20
 - 2-ая – от 20 до 50
 - 3-ая – более 50 микробных тел в поле зрения при увеличении 630

Уреазные экспресс-методы

- Тесты состоят из носителя, содержащего мочевины, и фенол-рот в качестве индикатора pH.
- Под действием уреазы бактерий происходит гидролиз мочевины с образованием аммиака, сдвигающего pH среды в щелочную сторону.
- Степень инфицированности оценивается по времени наступления и выраженности реакции, которая оценивается по степени +, ++, +++.

Уреазные экспресс-методы

- кампи-тест,
- кло-тест,
- де-нол тест,
- хелпил тест
- и другие.



Серологические методы

- **Выявление антител к НР методом иммуноферментного анализа (ИФА).**
- **Выявление фрагментов генома НР в средах (например, в слюне, кале) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).**

Другие методы определения НР

- **Уреазный дыхательный тест.**
 - После введения мочевины, меченной изотопом С14 или С13, регистрируется концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Считается «золотым стандартом» диагностики НР инфекции и контроля полноты эрадикации. Его чувствительность – 95%, специфичность – 100%.
- **Микробиологический метод.**
 - Используется для выявления чувствительности НР к антибиотикам при лечении устойчивых форм заболеваний.

Первичная диагностика НР и оценки эффективности эрадикации

- Для первичной диагностики достаточно использовать один метод (цитологический или уреазный).
- Для оценки эффективности эрадикации, которая проводится через 4 недели после окончания лечения, необходимы 2 метода.

РН-метрия желудка

В соответствии с принятыми критериями кислотообразование в теле желудка натошак и после стимуляции гистамином оценивают следующим образом.

Натошак:

- рН 0,9-1,5 – гиперацидность;
- рН 1,6-2,0 – нормацидность;
- рН 2,1-5,0 – гипоацидность;
- рН более 6,0 – ахлоргидрия.

После стимуляции:

- рН 0,9-1,2 – гиперацидность;
- рН 1,2-2,0 – нормацидность;
- рН 2,0-3,0 – умеренная гипоацидность;
- рН 3,0-5,0 – выраженная гипоацидность;
- рН более 6,0 – истинная ахлоргидрия.

Пример

диагностического заключения

- **Хронический антральный гастрит с повышенной секреторной и Нр-опосредованной кислотообразующей функцией желудка в фазе обострения.**
- **Хронический атрофический аутоиммунный гастрит тела желудка со снижением секреторной и кислотообразующей функции желудка в фазе обострения.**

ЛЕЧЕНИЕ

- **Хр.гастрит не служит показанием к госпитализации!**
- **Больной госпитализируется только при необходимости сложного обследования и затруднениях в дифференциальном диагнозе.**
- **При аутоиммунном гастрите госпитализация может быть показана по поводу тяжелой В12-дефицитной анемии.**

ЛЕЧЕНИЕ

Цели терапии

 Предотвращение развития предраковых изменений СО желудка – кишечной метаплазии и дисплазии СО!

Критерии эффективности терапии

- Эрадикация Нр
- Уменьшение признаков активности ХГ
- Отсутствие прогрессирования атрофии

ЛЕЧЕНИЕ

Немедикаментозное лечение

- Отказ от курения
- Избегать приема НПВП
- Рациональный образ жизни
- Диета не имеет самостоятельного значения как лечебная мера при ХГ (только при обострении)

Лекарственная терапия

Хр. неатрофический гастрит

- Эрадикация Нр
- Антисекреторные препараты **4 – 6 нед**
- Прокинетики и цитопротекторы при синдроме диспепсии.

Хр. атрофический гастрит

- Эрадикация Нр
- Цитопротекторы 2 – 3 недели
- Заместительная терапия (препараты HCl, лечение B12-дефицитной анемии)

Особенности диеты в период обострения

- **Диета стол №1**
- **Исключение факторов, провоцирующих обострение**
- **Дробное питание 4-5 раз в день**
- **Исключение продуктов, обладающих сокогонным действием, углеводы, жареное.**
- **Включение слизистых супов с отрубями при повышенной секреции.**
- **Обеспечение механического, термического и химического щажения желудка.**

Антисекреторная терапия

- *при повышенной и нормальной кислотности*
 - ингибиторы протонной помпы (омепразол 20 мг 2р/д, пантопразол, рабепразол, нексиум)
или
 - блокаторы H_2 -рецепторов гистамина II или III поколения (ранитидин 150мг 2 р/д или фамотидин 20мг 2 р/д)

Дополнительно:

- невсасывающиеся антациды (фосфалюгель через 1-1.5 часа после еды 3 р/д)

Нормализация кислотообразующей функции

- *при пониженной кислотности*
 - заместительная терапия после обострения (желудочный сок, ацидин-пепсин, бетацид, лимонтар)
 - ферменты при вторичной внешнесекреторной недостаточности (панзинорм, мезим форте, панцитрат, креон и другие)

Нормализация моторики

- **при спастическом компоненте –
миотропные спазмолитики,
холинолитики**
- **при гипомоторике и наличии
рефлюксов – прокинетика
(метоклопрамид – церукал,
мотилиум)**

Повышение защитных свойств слизистой при секреторной недостаточности или эрозиях

- **сайтотек,**
- **вентер,**
- **де-нол (препараты висмута)**

Средства с гастропротективным эффектом (цитопротекторы)

Назначаются при гастритах с выраженной секреторной недостаточностью и/или наличии эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны.

- **Обволакивающие и вяжущие средства:**
 - Сукральфат (вентер) 0,5 – 1 г 4 раза в сутки;
 - Коллоидный субцитрат висмута (де-нол) 120 мг 4 раза в сутки
 - Альгиновая кислота
- **Синтетические аналоги простагландинов**
 - Мизопростол (цитотек, сайтотек) 200 мг 4 раза в сутки

Эрадикация Нр - инфекции

- **Использование 3-х или 4-х компонентной схемы в течение 7-14 дней**

Коррекция анемии

- При В-12 дефицитной анемии – заместительная терапия цианкобаламином
- При железодефицитной анемии – препараты железа

Дополнительные способы

- **Фитотерапия с учетом кислотности желудочного сока**
- **Витаминотерапия**
- **Физиотерапия**
- **Санаторно-курортное лечение в фазе ремиссии**

Невсасывающиеся антациды

- Содержащие алюминиевую соль фосфорной кислоты: фосфалюгель, альфогель.
- Алюминиево-магниевые антациды: маалокс, маалокс-70, магалфил, ремагель, гастал, дайджин, гелюсил, гелюсил-лак, алмагель, алмагель-А, алмагель-Нео и другие.
- Алюминиево-магниевые антациды с добавлением альгината: топал, топалкан.
- ***Препараты назначаются в межпищеварительной фазе, через 1-1,5 часа после еды 3 раза в день и на ночь. Длительность курса от 2 до 3-4 недель в зависимости от заболевания.***

Терапия первой линии



Российские стандарты по лечению заболеваний,
ассоциированных с *H.pylori*

- ИПП (УЛЬТОП)
20 мг 2 р/сут
- Кларитромицин
(ФРОМИЛИД, КЛАЦИД)
500 мг 2 р/сут
- Амоксициллин (ХИКОНЦИЛ)
1000 мг 2 р/сут
или
Метронидазол 500 мг 2 р/сут
Курс лечения 14 дней

«...сочетание кларитромицина с
амоксициллином признано более
предпочтительным, чем сочетание
кларитромицина с метронидазолом,»

Контроль эрадикации проводится через 4 – 6 недель после окончания курса терапии

КАКИМ МЕТОДОМ?

- ✓ **Дыхательный изотопный метод!**
- ✓ **Быстрый уреазный тест**
- ✓ **Гистологический метод**

Терапия второй линии



- ИПП (УЛЬТОП) 20 мг 2 р/сут +
 - Висмута субсалицилат /субцитрат 120 мг 4 р/ сут +
 - Метронидазол 500 мг 3 р/сут +
 - Тетрациклин 500 мг 4 р/сут
- Курс лечения –14 дней

Маастрихт 3

Неэффективность 1 и 2 схем, что делать?

- **Возможность комбинации высоких доз амоксициллина (750 мг 4 р/д 14 дней) с высокими (4-кратными) дозами ИПП.**
- **Замена метронидазола в квадротерапии фуразолидоном 100-200 мг 2 р/д**
- **Альтернативная комбинация:
ИПП + амоксициллин + рифабутин 300 мг/сут;
ИПП + амоксициллин + левофлоксацин 500 мг/сут**
- **Подбор а/б с учетом индивидуальной чувствительности данного штамма Нр**

